

Datos Personales							
Nombre:	MIGUEL FRANCISCO MAESTRE OÑATE	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2015-11-05	Edad	10 Años, 0 Meses, Y 13 Días
Identificación:	TI - 1066294950	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	
Correo Electrónico:	Zmonate_93@hotmail.Com - 1066294950			Dirección:	MZ 17 CASA 2A URBANIZACION DON MIGUEL		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		ZORELA OÑATE - Parentesco (madre) - Teléfono (3183776364)					

Apertura psicología del 2025-09-24 11:21:24: 10 años, 0 meses, y 13 días

DATOS GENERALES

Remisión

Particular

DX principal

F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

DX Relacionado 1

F948 - OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NINEZ

Código de consulta

890308 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

La señora Zorella María Oñate como madre refiere, “El tema es conductual, se altera, se irrita, es contestón, no acata órdenes, tengo que decirle las cosas hasta 5 veces para que haga caso” “quiere que se haga es lo que él dice” “en la escuela en cuanto al rendimiento si le va bien” “cuando le gustan las cosas las hace concentrado, cuando no le gusta no las hace” “Al papá si le hace caso a mí no”.

Enfermedad Actual

Acude debido a la presentación de sintomatología caracterizada por alteración en el estado de ánimo, conductas disruptivas y desadaptativas, verborrea, conducta desobediente, irrespeto hacia la figura materna, dificultad para las relaciones interpersonales, selectividad en las preferencias, hiperactividad constante, atención dispersa en algunas actividades, con cuadro de evolución desde hace 6 años aproximadamente. Los síntomas se han agudizado hace un año presentando irritabilidad, conductas desafiantes, berrinches, llanto constante, presenta alteraciones en la conducta en contexto escolar, conducta autolesivas de golpearse el pecho, frustración e ira ante actividades que se le dificulta resolver. Realiza actividades de autocuidado de manera independiente y conserva los ciclos del sueño.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Circuncisión

Tóxicos

No Refiere

Traumáticos

Ninguno

Medicación

No Refiere

Paraclínicos

No Refiere

Hospitalizaciones

Si

Patología

No Refiere

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo

21 Años

Enfermedades De La Madre

No

Único Embarazo

Primero

El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica

Si

Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo

No

Estado De La Madre Durante El Embarazo

Normal

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Natural	Causa De La Cesárea NA
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3100
Talla Al Nacer 50 CM	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido Si, Por Causa De Ictericia.

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2 M	Rolado 3 M
Sedente Solo 6 M	Gateo 9 M
Bípodo Sin Ayuda 9 M	Marcha 10 M
Lenguaje Verbal 14 M	Lenguaje Verbal Fluido 4 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Hipertensión Familia Paterna Y Materna	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente cursa el grado tercero en la escuela Gimnasio bilingüe Jean Piaget, con buen rendimiento académico, sin embargo, presenta conductas de hiperactividad y selectividad con los compañeros.
Historia laboral NA
Historia familiar Actualmente vive con los padres el señor Miguel Francisco Maestre Guerra con 34 años, la señora Zorella María Oñate con 31 años y el hermano José Miguel Maestre de años, basada en la entrevista psicológica se encuentra una buena relación familiar.
Historia social Le gusta participar en eventos sociales que están relacionados con la musica y el baile, presenta dificultades en el seguimiento de instrucciones y la espera de turnos, sin embargo, se esfuerza por cumplir algunas reglas o normas. Se relaciona con algunos compañeros e interactúa con ellos y en cuanto al área familiar conecta muy bien con la mayoría de los familiares.
Historia socio-afectiva Presenta cambios emocionales y conductuales desde los 2 años de edad, agudizándose hace 2 años, luego de realizar prueba Neuropsicológica se entrega Dx Autismo grado 1 - en estudio, se muestra predispuesto, con verborrea, selectivo en cuanto a las relaciones interpersonales y las comidas, frio y plano en las manifestaciones de afecto con algunas personas.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial Se realizó una evaluación psicológica inicial mediante entrevista semiestructurada dirigida a la madre, complementada con observación directa en el contexto clínico y juego terapeutico con el paciente, con el fin de explorar el estado emocional y conductual. Durante la entrevista, se recabó información relevante sobre antecedentes personales, familiares y escolares, así como sobre el curso y características de la conducta hiperativa referida. En la observación clínica, se identificó un patrón conductual impulsivo, bajo nivel de autorregulación emocional y tendencia a la inquietud motora. Los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados no evidencian sintomatología clínicamente significativa de depresión o ansiedad en el momento de la
--

evaluación. Se considera necesario continuar con un proceso de valoración integral que permita delimitar con mayor precisión el perfil funcional, cognitivo y emocional del paciente.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica No refiere
Intervención neurológica No refiere
Intervención neuropsicológica Intervención y control por Neuropsicología con DX F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención + R463 Hiperactividad, CIT de 134 capacidad general intelectual muy superior. Según informe concluye “con algunas dificultades en procesar la información simbólica, leve fuga de ideas, quiere hacer las cosas rápidas y con el mínimo esfuerzo, poca motivación por tareas escolares, problemas adaptativos, de interacción, nervioso, comportamientos disruptivos crónicos” “necesidad de rehabilitación en memoria de trabajo y procesamiento de la información”. Dr Jahyner Guzman. Control con Neuropsicología el día 31 Enero de 2024 según conclusiones y comentarios por le profesional refiere “Paciente con signos clínicos caracterizados por distractibilidad, no se regula, quiere hacer las cosas corriendo, no modifica la conductas tras las reflexiones, se queja todo el tiempo, se levanta del puesto de manera permanente, presenta conductas bizarras, los problemas adaptativos, como lavarse las manos de manera compulsiva, poca flexibilidad, angustiarse de manera constante por no estar en un lugar, decir no rotundamente a tareas porque no quiere esforzarse, no contacto visual, se auto agrede, fuga de ideas muy leves, algunas dificultades en la interacción pueden determinar que quedan residuos de un cuadro mayor como el espectro autista, pero que no cumplen los criterios para este diagnóstico, el paciente se mostró desmotivado a realizar las actividades de memoria auditivo verbales y de memoria visual, las respuestas en fluidez verbal semántica en la categoría de frutas fueron positivas, con respuestas negativas en la tarea de animales y fluidez fonológica, alto nivel de comprensión pero con marcada dificultad para modificar su comportamiento. Con impresión Dx F841 Autismo atípico – en estudio F900 Perturbación de la actividad y de la atención + R463 Hiperactividad, CIT DE 134, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL MUY SUPERIOR, con necesidad de apoyo, supervisión. Dr. Jahyer Guzman.
Otras intervenciones Intervención por Neurología Pediatrica con Dx F900 Perturbación de la actividad y de la atención, E668 Otros tipos de obesidad, cita el 26 Agosto de 2023 y remite a consulta primera vez por especialista en Endocrinología pediátrica y continuidad en Psicología. Dr. Víctor Guerra.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental El paciente Miguel Francisco Maestre Oñate, menor de 8 años, asiste a consulta psicológica en compañía de su madre, la señora Zorella Oñate. Durante la entrevista se observa hiperactividad motora evidente, con dificultad para mantener una postura sedente estable y frecuentes movimientos corporales. Se muestra ansioso e inquieto, con tono de voz elevado y discurso espontáneo, de lenguaje expresivo y fluido para su edad. El saludo inicial es plano, aunque mantiene una actitud colaboradora y participativa durante la sesión. Presenta orientación autopsíquica conservada, adecuada conciencia de sí mismo y del contexto inmediato. Mantiene escaso contacto visual, pero demuestra disposición para responder a las preguntas formuladas y receptividad ante las actividades propuestas. La atención se observa fluctuante, con facilidad para distraerse ante estímulos externos y dificultad para mantener la concentración sostenida en actividades estructuradas. Requiere reorientación frecuente por parte del adulto para retomar la tarea. La concentración se mantiene por cortos periodos, especialmente cuando las actividades son de su interés. Se evidencia reconocimiento de los episodios conductuales referidos por la madre, mostrando comprensión básica de las situaciones descritas. No se observan alteraciones en el curso o contenido del pensamiento, ni signos de ideación delirante o alucinatoria.
Ciclos del Sueño Los ciclos del sueño se encuentran conservados, aunque se requiere intervención y supervisión constante por parte del adulto responsable para favorecer la adecuada higiene del sueño. El menor tiende a postergar la hora de descanso, manifestando resistencia a acostarse temprano debido a su preferencia por continuar en actividades lúdicas y de juego antes de dormir.
Apetito El apetito se encuentra conservado, aunque se observa una ingesta alimentaria elevada en comparación con los requerimientos propios de su edad. El menor se encuentra actualmente en proceso de adopción de hábitos de alimentación saludable, dado que presenta peso por encima del rango ideal para su edad y talla. Muestra predilección por alimentos dulces y ultraprocesados, lo cual dificulta el mantenimiento de una dieta equilibrada y requiere acompañamiento familiar para la regulación de su patrón alimenticio.
Actividades de Autocuidado El menor presenta independencia funcional para realizar las actividades básicas de autocuidado (aseo personal, vestido y alimentación); sin embargo, requiere supervisión y acompañamiento del adulto debido a su tendencia a distraerse con facilidad o prolongar el tiempo necesario para completar las tareas. Se observa baja autorregulación del ritmo y secuencia de las actividades, por lo que se recomienda mantener rutinas estructuradas y recordatorios externos que favorezcan su autonomía.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V): F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION
Establecido por primera vez No
Objeto de atención clínica Autismo atípico - En estudio

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención
Objetivo General Promover la regulación conductual y emocional del paciente mediante una intervención psicológica integral que permita reducir la conducta hiperativa, mejorar la atención sostenida, aumentar la motivación escolar y fortalecer estrategias adaptativas de afrontamiento.
Objetivos Específicos Sensibilizar a los padres acerca de las alteraciones presentadas en el niño y entregar pautas de manejo en la conducta y comunicación asertiva en el hogar para promover el avance.

- Entrenamiento en habilidades sociales y comunicación asertiva, para favorecer el manejo frente a la frustración.
- Aplicar técnica ABA para extinguir las conductas disruptivas y enseñar conductas socialmente aceptables.
- Favorecer los procesos cognitivos básicos y superiores a través de actividades dinámicas que fomentan el aprendizaje, para mejorar el comportamiento en todos los contextos.
- Fortalecer las conductas adaptativas conservadas, para mejorar la calidad de vida.

Sugerencias e Interconsultas

Control por Neuropsicología en 1 año.

Observaciones y Recomendaciones

- Continuar con las terapias de Psicología de manera prioritaria (3 paquetes por 12 sesiones cada mes).
- Implementar por parte de la Institución Educativa el Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR (Subsección 3 Esquema de atención educativa – ARTÍCULO 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión escolar), con el objetivo de favorecer el aprendizaje significativo y la motivación en el niño. Para lograr lo antes dicho es necesario aplicar estrategias de enseñanza que permitan el debido ajuste de logros y competencias según el nivel en el que se encuentra actualmente de acuerdo a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente. Se sugiere el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que se encuentre en curso.
- Siempre dar un trato digno y con respeto al niño.
- Aplicar refuerzo positivo con elogio verbal en aquellas conductas adaptativas y positivas que emita.
- Sentarse cerca del docente (si el alumno es más alto que los demás compañeros, su sugiere sentarlo en un lado de las filas de adelante para evitar obstruir la vista de los demás y dar cumplimiento a la inclusión escolar).

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER